



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رابعياً : كريمه عبده شكيوي مليجي

المحافظة : القاهرة الحي / المدينة : مصر القديمه العنوان : +++

رقم البطاقة : 26912060102306 رقم التليفون : 01129950840 تاريخ تسجيل الإستمارة : 19-09-2026

العمر (تاريخ الميلاد) : 06-12-1969 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي : (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه : (-----) التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام اشعه مقطعيه علي البطن والصدر بالصبغه قسم العلاج : الاورام

[11127]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : ----- التوقيع : (-----)

الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : ----- التوقيع : (-----)

الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : ----- التوقيع : (-----)

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة ومدير المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----

خطة العلاج : -----

المستشفى : ----- قسم : -----

جهة العلاج : ----- نفقات : -----

ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: كريمة عبده شكيوي مليح National ID: 26912060102306	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest and abdomen
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

مملكة البحرين
السلطنة

البحرين
السلطنة
البحرين
السلطنة



99362713

2738

B9



البحرين
السلطنة
البحرين
السلطنة
البحرين
السلطنة
البحرين
السلطنة



Pathology Report
 قسم الأمراض التشريحية - مستشفى الملك سعود
 قسم الأمراض التشريحية - مستشفى الملك سعود

Patient Name	: السيدة / مريم محمد بن علي	Request No.	: 13003763
Patient No.	: 126912060102306	Request Date	: 16/05/2022
Path No.	: 1292/2022	Verification Date	: 22/05/2022
Sex	: Female	Financial Category	: ايرام وكيه السلام - مملكة
Age	: 52 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: maria mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data
 Rt breast lesion

Nature of the specimen:
 Tru cut biopsy

Gross Examination:
 Multiple greyish white & hemorrhagic tissue cores up to 2 cm, totally submitted

Microscopic examination:
 • Histological type: Invasive duct carcinoma
 Grade II (differentiation & nuclear pleomorphism & mitosis): (3+2+1)

Diagnosis:
 Rt breast lesion, tru cut biopsy
 Invasive duct carcinoma, grade II
 (3+2+1)

Prof. Lubna Omar

Verified by:
 dr. esra magdy

Printing by: maria mohamed youss



MINISTRY OF HEALTH
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

NUCLEAR MEDICINE UNIT



٢٠١٥ / ١٢ / ١٥

^{99m}Tc-MDP BONE SCAN

Paternal information: skeletal surveying to detect multiple metastases.
Technique: Anterior and posterior whole body scan per 20 mCi ^{99m}Tc-MDP.
Administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP.

RESULTS

- No evidence of multiple metastases.
- Heterogeneous radiotracer uptake in the lumbar vertebrae, suggestive of degenerative changes.
- Both kidneys are normally seen.

Conclusion

No definite evidence of metastatic disease.

Thanks for reference

Nuclear Medicine Unit

Dr. Sherein Mohady, MD



مملكة العربية السعودية
وزارة الصحة العامة
الهيئة العامة للغذاء والدواء

GR

MDT FORM
33/6.1292

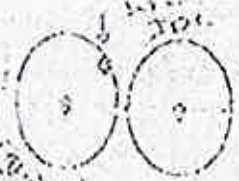
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الرياض

NAME	كريمة محمد بن شبيب	DOB	10/1/60
AGE	35	SEX	F
MEMBERSHIP NO.	1000000000	PHOTO	
OP		MAILED NAME	
OP NUMBER		Family name	

DA / HEN
10/1/60

RDC GR			
ES	6/8	ES	8/8
HERZ	10%	HERZ	10%

Left: 10 o'clock (exterior)
Right: 10 o'clock (exterior)
+ 10 o'clock (exterior)
CRCLP - free



MDT OVERVIEW

for upper Rt. WLE of 31/1/60
included in 100

SIGNATURE

[Handwritten signature]

Patient Name: السيدة / كبريا محمد علي
 Patient No: 26912060102306
 Path No: 1282/2022
 Sex: Female
 Age: 62 Y
 Referring Doc:
 Request No: 13003763
 Request Date: 16/05/2022
 Verification Date: 29/05/2022
 Financial Category: ارقام وكر السلام
 Department: Out Patient
 IHC No: 1
 Registered by: i. manwa mohamed yz

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:
 Right breast lesion

Material: tissue specimen
 Procedure: tru cut biopsy

Gross Examination:

Multiple grayish white & hemorrhagic tissue cores up to 2 cm, totally submitted

Sections prepared from paraffin block for immunohistochemical staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

Microscopic examination:

• Histological type: Invasive duct carcinoma

Grade II (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (3+2+1)

ER: Strong nuclear reaction in 30% of tumor cells (Allred score 6/8)

PR: Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (Allred score 8/8)

Her-2: Weak incomplete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 1+)

Ki67: 10% nuclear reaction in tumor cells

Appropriate tissue control were reviewed

Diagnosis:

Right breast lesion, tru cut biopsy.

Invasive duct carcinoma, grade II

• IPI

Verified by:

Dr. Asmaa Inagdy

Printed Date: 30/05/2022 09:15:12

Page 1 of 2

Related By: i. manwa mohamed yz

Patient Name: Nehmdo Abdel-Hamid Atalla
Referring Physician: Prof. Dr.

Date: 14/2/2023

Whole body PET/CT

History and clinical data:

63 years old female patient with HD

Radiopharmaceutical:

F-18-FDG mCi injected I.V.

Fasting blood glucose:

mg/dl

Technique:

Approximately one hour following the IV injection of the radiopharmaceutical, a total body PET - CT was acquired from mid thigh to base of skull with the arms extended above the head. CT was acquired for the purpose of anatomic localization & attenuation correction. Data is processed & displayed according to departmental protocol.

Report:

Follow up PET/CT study for a known case of HD, compared to the previous PET/CT examination dated 12/6/2022, the current scan revealed:

Hepatic Reference: max SUV ~3.4.

Head & Neck:

- Progressive metabolic course regarding the currently noted right cervical upper & lower deep level II, III, IV, V, intra parotid LNs with FDG activity (metastatic lymphomatous nodal lesions) currently seen the largest & most active at the right side level (V), measures 1.3cm with max. SUV~11.5 (DS 5), compared to the last study (max SUV~ 8, most activity at right sided level IV LN, size largest one intra parotid LN 1.6cm)



(
A
A

(C.H.)

MD FORM

12. *h. m. m.*

Age
Menstrual stress
SES
SES x stress

1890-1891

CA / HCL
Catal Data

6/8 1963

[Faint handwritten notes at the bottom of the page, possibly indicating time or date.]

Chester

THE OUTCOME

to report R. L. ...
... ..

2000

Patient Name
Patient No. 269
Path. No. 2286
Sex Female
Age 62 Y
Referral Doc

12306

Examination No.
Examination Date
Examination Unit
Histologic Category
Department
Registered by

Date Recd. 1/10/00

Clinical Data:

A known case of breast cancer

Nature of the specimen
Auxiliary clearance

Stress Examination
A. Paraffin tissue

Received from Dr. [unclear] 14 lymph nodes

Microscopic examination

Reveals preservation

lymph nodes are

found in the

diagnosis

known case

Reactive lymph

reaction granular

Prof. [unclear] hereby

Dr. Menia Nabli

nodal architecture is subcapsular situated. The
lymph nodes are well preserved and have
normal architecture. The lymph nodes are well
preserved and have normal architecture.

There is no evidence of metastasis & foreign body

Verified by

Dr. [unclear]

Printed by [unclear]

